Signature Not Verified
Digitally signed by Medis UKC MAribor

Oddelek za psihiatrijo

MARIBOR, 09.01.2023

ODPUSTNO PISMO

DRAUČBAHER PETER
OŽBALT 53

2361 OŽBALT

Rojen-a	17.09.1984	KZZ: 040003336
Reg.št.	5025068692	
Podjetje	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROV	
Dodat.zav.		
Zap.štev.	681226 18	
Matična št.	970095	
Velj.nap.	**05.12.2021**	**Obseg poobl. 1,2,3**

Datum, ura sprejema	*Dat.,ura adm.odp.*	*Št. hospital. dni*
05.12.2021 08:20	10.02.2022 09:04	67

Datum in ura odpusta: 10.02.2022 13:00 *Merilo ustreznosti sprejema:* 18

Sprejemni zdravnik: dr. ANJA PLEMENITAŠ ILJEŠ, dr. med., spec. psihiatrije
Sobni zdravnik: dr. PETRA KOPRIVNIK, dr. med., spec. psihiatrije
Predstojnik oddelka za psihiatrijo: JURE KOPRIVŠEK, dr. med., spec.psihiatrije

DIAGNOZA

02.02.2022 - F200 Paranoidna shizofrenija
02.02.2022 - L210 Diseboreja lasišča

IZVIDI MEDODDELČNIH OBRAVNAV

FE: 421 Laboratorij nuklearne medicine
Datum, ura obravnave: **06.12.2021 10:41**
Zdravnik: prim. MITJA TOPALOVIČ, dr. med., spec. internist

FE: 540 Oddelek za kožne in spolne bolezni
Datum, ura obravnave: **20.01.2022 14:00**
Zdravnik: prim. mag. PIJ BOGOMIR MARKO, dr. med.,svetnik, spec. dermatovenerolog
Dg.: L210 Diseboreja (lojavica) lasišča

Bolnik je hospitaliziran na Oddelku za psihiatrijo. Odkar se je ostrigel, so opazili nekoliko eritematozna, luščeča se žarišča na centralnem in frontalnem delu lasišča.
V anamnezi bolnik pove, da so žarišča prisotna že vrsto let, da pa so v času hospitalizacije bolj intenzivna in se sedaj po skrajšanju las močneje vidijo.
Sicer drugih kožnih težav v preteklosti ni imel. Spremembe so občasno srbeče, zelo veliko praska kožo lasišča.
OA in FA: negativna glede kožnih bolezni, vključno z luskavico.

St. derm.: na frontalnem delu lasišča je prisotna slika androgene alopecije s podaljšanimi frontotemporalnimi recesusi in praktično že s konfluiranjem alopecije frontalnega in centralnega dela. Na omenjenem, neporaslem delu lasišča belkasto sive luskaste obloge, brez posebnega vnetja, na večih mestih ekskoriacije in sledovi praskanja kože.
Močan prhljaj retro in supraaurikularno, elementov luskavice lasišča zaenkrat ne morem potrditi.

Mnenje: glede na anamnestične podatke in klinično sliko gre za diseborejo lasišča z očitno močnim srbežem. Dodatno so možni tudi elementi nevrotičnih ekskoriacij oz. ekskoriacij ob bolezni, zaradi česar je bolnik hospitaliziran na Oddelku za psihiatrijo.

Vsekakor predlagam v terapiji pranje lasišča z Oronazol šamponom 2x tedensko, šampon je potrebno pustiti na lasišču 5-6 min., nato sprati. Po pranju lasišča Belosalic lot. 2x dnevno 3-5 dni do umiritve luščenja in vnetja ter srbeža, nato pa tanko nanesti ob večerih pred spanjem Afloderm kremo do popolne umiritve vnetja in srbeža.
Kontrola pri nas v primeru neuspeha lokalne terapije in ponovnega poslabšanja kožnega stanja preko naše konziliarne službe.
V kolikor je le možno, je potrebno bolnika vzpodbujati, da lasišča ne praska.
ns

LABORATORIJSKI REZULTATI

05.12.2021 12:00 TSH=1.62;

05.12.2021 12:56 S-folati=20.2; S-vitamin B12=275;

05.12.2021 12:56 K-Hemogram=.; K-levkociti=6.92; K-eritrociti=5.52; K-hemoglobin=137; K-hematokrit=0.42; MCV=75.4; MCH=24.8; MCHC=329; K-trombociti=193; Diferencialna krvna slika=.; K-nevtrofilni granulociti=4.17; K-limfociti=2.00; K-monociti=0.63; K-eozinofilni granulociti=0.10; K-bazofilni granulociti=0.02; K-nezreli granulociti=0.02; K-nevtrofilni granulociti=60.3; K-limfociti=28.9; K-monociti=9.1; K-eozinofilni granulociti=1.4; K-bazofilni granulociti=0.3; K-nezreli granulociti=0.3; S-urea (sečnina)=3.1; S-kreatinin-E=59; Ocena GF=>90; S-CRP=<3.0; S-bilirubin celokupni=4; S-bilirubin direktni=1; S-AST (GOT)=0.51; S-ALT (GPT)=0.46; S-gama GT=0.34; S-natrij (Na)=138; S-kalij (K)=3.81; S-kloridi (Cl)=107; S-holesterol=4.30; S-trigliceridi=3.01; S-HDL-holesterol=1.50; S-LDL-holesterol=2.2; U-specifična teža=1.015; U-pH=7.5; U-nitriti=negativno; U-proteini=0; U-glukoza=0; U-metilketoni=0; U-urobilinogen=<17; U-bilirubin=0; U-eritrociti=27; U-levkociti=11; U-bakterije=25; U-cilindri=0; U-epitelne celice=0; U-eritrociti=3 - 5; U-levkociti=0 - 5; U-bakterije=Malo; U-cilindri=0; U-kristali Ca oksalat=Prisotni; U-epitelne celice=0;

ZAKLJUČEK

37-letni pacient, ki je bil pri nas spomladi 2021 enkrat hospitaliziran zaradi psihotične motnje (dg. akutna psihotična motnja, shizoidna OM), je bil tokrat pripeljan z reševalnim vozilom. Doma naj bi davil mamo, pobegnil in se zatekel k sosedom, kjer naj bi navajal, da si želi biti hospitaliziran. Po prejšnji hospitalizaciji je zdravljenje opustil. V tem času je tudi izgubil delovno razmerje.

Sam je ob sprejemu navajal, da se je skregal z mamo, hotel jo je tudi zadaviti, ker mu je povzročila veliko hudega v preteklosti. Avtizem je kriv, da sta se z mamo kregala. Zlorabljala ga je tako fizično kot psihično. Mama in brat živita v Ljubljani, z njima se ne razume dobro. Sam je po hospitalizaciji kmalu pustil terapijo, jemal jo je kakšen mesec ali dva, razloga ne navede. Pri amb. ni bil nikoli, tudi s koordinatorjem obravnave v skupnosti po odpustu ni sodeloval. Razmišljal je tudi o tem, da bi rad umrl, a ni našel načina ali moči, da bi to naredil. Pri nas ne bi delal samomora. Ponoči je sicer še spal, imel normalen apetit, sam si je pripravljal obroke. Telesno nima kakšnih posebnih težav, nima diete. Pred nekaj dnevi je pil alkohol, sicer ne jemlje nobenih drog in ne kadi trave. Alergije na zdravila zanika.

Psihični status ob sprejemu: luciden, vsestransko orientiran, med pogovorom nekoliko zadržan, deluje napet, vedenjsko se še kontroliran. Za daljši razgovor ni motiviran, na zastavljena vprašanja odgovarja v urejenih stavkih. Ob tem ne iznese jasnih zaznavnih motenj, nakazana pa je paranoidnost napram mami in bližnji okolici. V razpoloženju je vsaj disforičen, globlje depresiven ali privzdignjen se aktualno ne prikaže. Osebnostno deluje specifično strukturiran, navede prisotna občasna samomorilna razmišljanja, od katerih se aktualno popolnoma distancira in zagotovi, da nima samomorilnih namenov, potrdi, da je pred sprejemom doma napadel mamo na način, da jo je poskušal daviti. Aktualno ni heteroagresiven.

Higiensko je bil pomanjkljivo urejen, trezen (AT je 0,0 mg/l), orientacijski somatski status nevpadljiv.

Pac. je s sprejemom soglašal, sprejet je bil preko sive cone in po prejemu negativnih izvidov na SARS-CoV-2 seljen na varovano moško enoto.

V laboratorijskih izvidih pri pacientu prisotna mikrocitoza (MCV 75,4) sicer hemoglobin v mejah

normale. Trigliceridi povišani (3,01). Serumske vrednosti foaltov, vitamina B12 in TSH so v mejah normale. Urin na konvencionalne PAS: negativno.

Ponovno smo uvajali risperidon, ob tem lorazepam in hipnotik po potrebi. V nadaljevanju smo prešli na paliperidon in se s pacientom dogovorili za uvedbo depo preparata (Xeplion). Zaradi nezadostnega učinka smo antipsihotično terapijo v nadaljevanju augmentirali z aripiprazolom.

Šlo je za vnovično paranoidno psihotično epizodo, diagnostika ob prejšnji hospitalizaciji govori za akutno psihotično motnjo ob shizoidni osebnosti, klinično je verjeten shizofrenski proces.
Tekom hospitalizacije smo pridobili podatke o heteroagresivnem incidentu proti neznani osebi v Črni Gori v jeseni, ko je bil bolnik tam na dopustu v nekem hotelu. Bil je hospitaliziran v Črni Gori, izrečen mu je bil celo ukrep dvoletnega obveznega psihiatričnega zdravljenja z navodilom, naj se vrne na domači naslov. Objektivno je bil bolnik ob psihotičnem poslabšanju že večkrat resno heteroagresiven, zato smo sodišču zaradi bolnikove nekritičnosti in neadherence ob resni duševni motnji, zaradi katere je nujno vzrdževalno zdravljenje, predlagali nadzorovano obravnavo. Od zadnje hospitalizacije je bolnik funkcioniral zelo slabo, izgubil je službo, porabil prihranke in se zadolžil pri banki.
Sodišče je na naroku 10. 1. 2022 izdalo sklep o nadzorovani obravnavi.

Bolnik se v domačem okolju počuti kronično ogroženega. Nanašalno-paranoidnen je v odnosu do najbližjih svojcev, psihosocialno propada. V reševanje obsežne socialne problematike smo vključili socialno službo. Pacient se je strinjal je s podajo vloge za bivanje v stanovanjski skupnosti. Veliko težav je bilo z urejanjem socialnega statusa (ni imel zavarovanja, imel je finančne dolgove, izgubil je ključne osebne podatke za preklic bančnega računa v tujini itd.). Večkrat smo bili v stiku s policijsko postaje Radlje zaradi heteroagresivnega vedenja pred to hospitalizacijo, dobili smo pojasnilo, da bo postopek po pac. izjavi o dogodku zaključen.

Ob boljšem funkcioniranju bolnika smo 6. januarja zdravljenje nadaljevali na rehabilitacijski enoti, kjer je bil sprva še precej zaskrbljen, bal se je, da bi dobil forenzični ukrep. Zaradi depresivnega pomika razpoloženja smo uvedli sertralin. Z načrtom nadzorovane obravnave, intervencami socialne službe in selitvijo v stanovanjsko skupino se je razbremenil.
S pac. dovoljenjem smo mamo informirali o poteku zdravljenja, sam stike s svojci zavrača, v odnosu do njih ostaja paranoiden.

Zaradi sprememb kože v lasišču smo pac. konziliarno napotili k dermatologu, ki je podal sledeče mnenje: glede na anamnestične podatke in klinično sliko gre za diseborejo lasišča z očitno močnim srbežem. Dodatno so možni tudi elementi nevrotičnih ekskoriacij. Vsekakor predlagam v terapiji pranje lasišča z Oronazol šamponom 2x tedensko, šampon je potrebno pustiti na lasišču 5-6 min., nato sprati. Po pranju lasišča Belosalic lot. 2x dnevno 3-5 dni do umiritve luščenja in vnetja ter srbeža, nato pa tanko nanesti ob večerih pred spanjem Afloderm kremo do popolne umiritve vnetja in srbeža.
Vnetje kože se je ob uvedeni terapiji umirilo.

Ob odpustu je v relativni remisiji psihotične motnje, ki ima značaj psihotičnega procesa. Je umirjen, evtimen, ni produktivno psihotičen, osebnostno je shizoidno strukturiran, na spektru avtističnosti, ostaja slabše kritičen do paranoidnosti napram svojcem, sicer pa imponira adherenten. Znakov za avto- ali heteroagresijo ni. Vegetativne funkcije so urejene, tudi razpoloženje je v srednji legi, je pa čustveno slabše odziven. Zdravljenje bo nadaljeval ambulantno v okviru nadzorovane obravnave, nujno je vzdrževalno zdravljenje.

NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA
Pacient je premeščen/sprejet na NBO (po zaključeni akutni obravnavi):
od 7.01.2022 do 10.02.2022 (35 dni). Razlog upravičenosti: rehabilitacija

ODPUŠČEN

Splošna navodila ob odpustu
Terapija ob odpustu:

XEPLION 150 mg i.m. na 4 tedne, tretji odmerek prejel 2. 2. 2022
ARIPIPRAZOL Sandoz 5 mg zjutraj, eRp.sc.II
ASENTRA 100 mg zjutraj, eRp.sc.II
ORONAZOL ŠAMPON za lasišče 2 x tedensko (lahko uporablja redno; prejme s sabo)
AFLODERM krema za lasišlče zvečer (do zacelitve kože; prejme s sabo)

Aplikacija naslednjega depoja v naši urgentni ambulanti 3. 3. 2022 dopoldne, nato v ambulanti dr. Klemnove v ZD Adolfa Drolca Maribor 1. 4. 2022 ob 11h.

Pac. je vključen v nadzorovano obravnavo po sklepu sodišča za obdobje šestih mesecev od 10. 1. 2022. Zaradi reševanja socialnih zapletov osnovne motnje smo morali hospitalno obravnavo podaljšati. Ocenjujemo, da bo NO smiselna daljše obdobje. Pac. nima socialne mreže, s svojci ne želi stikov. V kolikor bo ambulantno funkcioniranje dobro, je smiselna napotitev na poklicno rehabilitacijo. Odpuščen je v stanovanjsko skupino Ozara Maribor.

Pac. je tekom hospitalizacije prejel prvi odmerek cepiva proti SARS-CoV-2 proizvajalca Pfizer dne 2. 2. 2022, drugi odmerek predvidoma 23. 2. 2022 (na enem od cepilnih mest).

pk/žm

Odpustni zdravnik (lečeči/sobni/dežurni)
dr. PETRA KOPRIVNIK, dr. med., spec. psihiatrije

Pacient mora odpustno pismo, ambulantni karton ali drugo medicinsko dokumentacijo izročiti svojemu osebnemu zdravniku ob prvem naslednjem obisku.

V primeru morebitnih naknadnih izvidov sledi Dodatek k odpustnemu pismu.

Spoštovani, vabimo vas, da podate vaše mnenje o zadovoljstvu z opravljeno zdravstveno obravnavo v UKC Maribor tako, da izpolnite vprašalnik. Pripravilo ga je Ministrstvo za zdravje v več jezikih, je anonimen in vam je neprekinjeno dostopen tako, da v svoj spletni brskalnik vpišete: zvem vprašalnik za paciente
Hvala za vaše sodelovanje !